

## 9. INSPECȚIA SISTEMULUI OSTEOMUSCULAR

Examinarea ortopedică pediatrică îmbracă aspecte particulare în raport cu vârsta pacientului și tipul patologiei pentru care se adresează.<sup>12,13</sup>

- în perioada neonatală și de sugar predomină afecțiunile congenitale (ex. piciorul strâmb, displazia coxo-femurală);
- mersul pe jos întârziat la un copil poate fi un alt motiv de prezentare la consult ortopedic, situație care ar putea fi cauzată de o encefalopatie sau o distrofie musculară;
- afecțiunile neurologice pot avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra sistemului osos în dezvoltare (ex. paralizie cerebrală, mielomeningocel, etc);
- după ce copilul merge în picioare se întâlnesc mai frecvent afecțiunile traumatiche, de la contuzii, entorse și fracturi simple (tasări, în lemn verde) și până la fracturi complexe, uneori multiple, deschise și cu asocieri de leziuni cerebrale sau/și ale organelor interne.

Înainte de efectuarea examenului fizic este necesară o anamneză minuțioasă care să releve istoricul achizițiilor motorii ale pacientului și eventualele afecțiuni în antecedente:

- se începe cu istoricul nașterii, cu detalii privind evoluția sarcinii;
- vor fi consemnate etapele de dezvoltare (vârsta la care copilul a stat pentru prima dată în picioare, când a început să se plimbe în timp ce se ținea de mobilier, când a mers independent);
- din antecedente nu trebuie omise posibilele alergii, spitalizări, intervenții chirurgicale, boli majore;
- în istoricul de familie se caută informații despre frați, părinți, bunici și oricare alte rude cu o problemă medicală similară cu cea a copilului.

Examinarea fizică include înălțimea și greutatea pacientului, o examinare aprofundată a coloanei vertebrale, toracelui, membrelor superioare și inferioare, urmărind în corelație cu vârsta pacientului:

- posturi, atitudini vicioase la diverse nivele ale corpului, (modificari de ax la nivelul membrelor – varus/valgus);
- mobilitatea articulară;
- dezvoltarea masei, tonusului și forței musculare;
- se va lua în considerare efectuarea unor manevre care să permită diagnosticul unor afecțiuni mai frecvente la o anumită vârstă și sex:
  - displazia luxantă coxo-femurală diagnosticată în perioada de sugar, mai frecventă la fete,
  - maladia Legg-Calve-Perthes cu incidență mai mare la băieți cu vârsta între 4 și 10 ani,
  - scolioza idiopatică juvenilă mai frecventă la sexul feminin.

*În cazul unei patologii malformative:*

Examinatorul trebuie să caute semne de deformare musculo-scheletică și dacă acestea există, să stabilească locația lor exactă și dacă se poate precizarea cauzei.

În acest scop este necesar să se stabilească:

- dacă este o afectare osoasă, articulară sau a țesuturilor moi;
- cât de accentuată este deformarea;
- dacă există posibilitatea corecției acesteia;
- care sunt factorii care au cauzat afecțiunea;
- dacă sunt asociate și alte simptome locale:
  - spasme musculare;
  - sensibilitate locală;
  - durere la mișcare.

## 10. EXAMINAREA GENU VALGUM/GENU VARUM

Sugarii și copiii sunt în mod frecvent prezentați chirurgului ortoped pentru evaluarea deformărilor axiale ale membrului inferior, în special cu sediul la nivelul genunchiului, mai frecvent întâlnite fiind 2 entități:<sup>12,13</sup>

- *genu valgum* – semnifică devierea axului membrului inferior la nivelul genunchiului cu apariția unui unghi cu deschidere *externă* și realizarea unui aspect al membrului inferior “în X”;

- *genu varum* – semnifică devierea axului membrului inferior la nivelul genunchiului cu apariția unui unghi cu deschidere *internă* și realizarea unui aspect al membrului inferior “de paranteze”.

Părinții pacienților în cauză reclamă atât aspectul cosmetic al deformării în ortostatism cât și aspectul mersului. De obicei, acești copii realizează mersul independent devreme, înainte de primul an de viață.

Alinierea axului la nivelul membrului inferior urmează un model predictibil în raport cu vârsta (fig. 9 A,B,C,D):

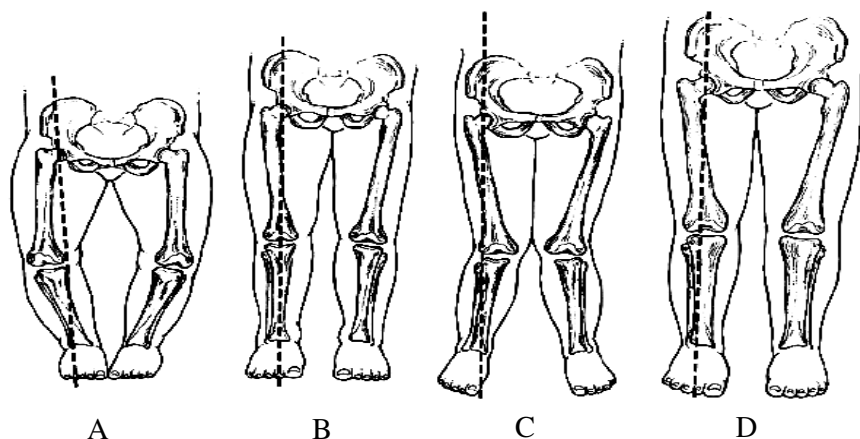


Fig. 9. Modificarea fiziologică a axului membrului inferior în raport cu vârsta (după Lovell modificat): A – sugar, B – 18-24 luni, C - 3½ ani, D – 7 ani.

- sugarii au de obicei o încurbare moderată în varus de-a lungul femurului și tibiei (10-15 grade);
- la 18-24 de luni axul membrului inferior este aproape drept;
- urmează o deviere în valgus care se dezvoltă treptat și este cel mai evidentă între 3 și 4 ani (8-10 grade);
- ulterior până la 7 ani, membrele inferioare sunt în ușor valgus care se mai modifică în foarte mică măsură (nu mai trebuie să apară varus și nici nu ar trebui să se accentueze valgusul).

O atenție deosebită trebuie acordată istoricului familial cu privire la existența acestor modificări.

Gradul de deformare al axului membrului inferior este măsurat cu un goniometru cu genunchii în extensie completă și se documentează prin efectuarea de radiografii și fotografii.

Radiografiile sunt o parte esențială a evaluării copilului cu vârsta peste 18 luni cu deformări pronunțate, mai mult de 20 de grade, când intră în discuție diversele forme patologice de genu valgum/varum și care necesită tratament ortopedic ± chirurgical.